

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Alergia Respiratória > Visão geral	asma, rinite alérgica, vias respiratórias, inflamação crônica, exposição repetida a alérgenos inaláveis, poluentes ambientais	LEVE	Considerar que asma e rinite frequentemente coexistem; orientar avaliação clínica estruturada, identificação de gatilhos e controle ambiental contínuo.
Alergia Respiratória > Rinite alérgica > Sintomas clássicos	espirros em salva, coriza abundante e clara, coceira no nariz, olhos, ouvidos e garganta, obstrução/congestão nasal	LEVE	Se os sintomas forem localizados e sem piora importante, observar em casa, reduzir exposição a poeira/ácaros e agendar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e plano de controle.
Alergia Respiratória > Rinite alérgica > Tosse associada	tosse seca, piora noturna, gotejamento pós-nasal, sinusite associada	MODERADA	Tosse persistente não deve ser tratada apenas com xaropes ou medidas caseiras; procurar avaliação médica para identificar a causa e tratar rinite/sinusite associadas.
Alergia Respiratória > Rinite alérgica confundida com infecção	“gripes” repetidas, “resfriados” frequentes, coriza, espirros, nariz escorrendo, congestão nasal	MODERADA	Suspeitar de rinite alérgica quando o quadro é recorrente; evitar uso repetido e indiscriminado de antibióticos e buscar diagnóstico correto com especialista.
Alergia Respiratória > Criança em creche	infecções respiratórias repetidas, melhora nas férias, piora ao retornar à creche	MODERADA	Considerar imaturidade imunológica, mas investigar rinite alérgica; se houver infecções recorrentes, o médico deve avaliar também imunodeficiência ou resposta esperada para a idade.
Alergia Respiratória >	sinusite, infecções,	MODERADA	Não banalizar a rinite;

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Complicações da rinite	necessidade repetida de antibióticos, acometimento de seios da face, olhos, ouvidos, garganta e pulmões		tratar adequadamente para evitar complicações e reduzir necessidade de antibióticos. Encaminhar ao especialista quando houver repetição de crises ou complicações.
Alergia Respiratória > Ronco e respiração oral	dormir de boca aberta, ronco crônico, obstrução de vias aéreas superiores	MODERADA	Ronco crônico não é normal; investigar rinite alérgica e/ou aumento de amígdalas e adenoides. Procurar avaliação médica programada.
Alergia Respiratória > Adenoide	obstrução nasal, roncos, amigdalites, otites	MODERADA	Quando houver suspeita de aumento de adenoides, encaminhar para investigação, pois pode haver impacto respiratório e infeccioso.
Alergia Respiratória > Sinusite	dor de cabeça, sensação de peso/pressão facial ao abaixar/levantar a cabeça, secreção nasal, obstrução nasal, tosse, febre	MODERADA	Procurar avaliação médica para diferenciar sinusite alérgica de infecciosa e instituir tratamento adequado; febre sugere maior necessidade de avaliação.
Alergia Respiratória > Tosse como sinal de alerta	tosse persistente, seca ou com expectoração, horário predominante, associação com outras doenças, uso de medicamentos	MODERADA	Tossir não é doença, mas sinal de alerta; se a tosse perdura, procurar atendimento médico para investigação clínica e exames complementares quando indicados.
Alergia Respiratória > Tosse noturna infantil	tosse na madrugada, vômitos após tosse, criança bem durante o dia	MODERADA	Investigar rinite, sinusite, refluxo gastroesofágico e asma; não repetir xaropes sem diagnóstico.
Alergia Respiratória > Asma > Sintomas	falta de ar, chiado, aperto no peito, tosse	MODERADA	Procurar avaliação médica para confirmar

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
típicos			diagnóstico, identificar desencadeantes e iniciar plano terapêutico com medidas de alívio e prevenção.
Alergia Respiratória > Asma > Terminologia	bronquite alérgica, bronquite asmática, asma	LEVE	Considerar os termos como denominações da mesma doença; orientar o paciente com clareza para evitar confusão e garantir tratamento correto.
Alergia Respiratória > Asma > Desencadeantes alérgicos	ácaros da poeira, fungos/mofos, pelos de animais, baratas, pólenes	MODERADA	Identificar e controlar gatilhos ambientais; reforçar controle domiciliar e considerar imunoterapia quando indicada.
Alergia Respiratória > Asma > Desencadeantes irritativos	odores fortes, mudanças de tempo, fumaças, poluição	MODERADA	Evitar exposição sempre que possível; se houver piora frequente, revisar controle da doença com o médico.
Alergia Respiratória > Asma > Outros desencadeantes	infecções virais/bacterianas, medicamentos, fatores emocionais, exercício físico, refluxo gastroesofágico, fatores ocupacionais	MODERADA	Mapear gatilhos individuais e atuar sobre eles; manter acompanhamento regular para ajustar o tratamento.
Alergia Respiratória > Asma > Crise leve em paciente já diagnosticado	tosse, chiado, sintomas conhecidos de crise	MODERADA	Seguir plano terapêutico previamente prescrito pelo médico; usar medicação de alívio conforme orientação e observar resposta.
Alergia Respiratória > Asma > Uso de prednisolona	crise de asma, melhora após corticoide oral	MODERADA	Não repetir prednisolona por conta própria toda vez que tossir; corticoide oral deve ser usado nas crises sob supervisão médica devido ao risco de efeitos adversos.

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Alergia Respiratória > Asma > Descontrole	necessidade frequente de medicação, pouca melhora apesar do tratamento	MODERADA	Se o medicamento está sendo usado corretamente e não há melhora, investigar fatores agravantes e revisar técnica, adesão e nível de controle em consulta regular.
Alergia Respiratória > Asma grave	asma grave, pouca resposta ao tratamento, necessidade de monitoramento	GRAVE/CRÍTICA	Requer acompanhamento regular, revisão do uso correto dos medicamentos e avaliação do controle da doença em cada consulta; procurar atendimento urgente se houver piora respiratória importante.
Alergia Respiratória > Bombinha de alívio	broncodilatador inalatório, alívio rápido das crises	MODERADA	Pode ser usada em qualquer idade quando prescrita; se houver necessidade muito frequente, isso sugere descontrole e exige reavaliação médica.
Alergia Respiratória > Bombinha preventiva	corticoide inalatório, uso diário e prolongado, prevenção de crises	LEVE	Manter uso contínuo conforme prescrição para controlar a inflamação dos brônquios e prevenir novas crises.
Alergia Respiratória > Técnica inalatória	impressão de não ter inalado direito, falha na técnica	MODERADA	Levar o dispositivo à consulta e demonstrar a técnica ao alergista; técnica incorreta reduz a eficácia do tratamento.
Alergia Respiratória > Encaminhamento precoce	criança de 2 anos com rinite e asma	MODERADA	O tratamento com especialista pode ser feito em qualquer idade; quanto mais cedo o diagnóstico e a definição das causas, melhores os resultados.
Alergia e Gravidez >	gestante com alergia,	LEVE	Priorizar controle

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Controle global	redução de crises, menos pronto-socorro, menos internações, menos complicações na gravidez e parto		adequado da doença alérgica durante a gestação, pois isso beneficia mãe e bebê.
Alergia e Gravidez > Asma na gestação	gestante com asma, uso de remédios, risco fetal por baixa oxigenação	MODERADA	A gestante pode e deve tratar a asma com segurança; o risco da asma sem controle é maior que os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos.
Alergia e Gravidez > Rinite na gestação	rinite na gravidez, necessidade de tratamento conforme gravidade	LEVE	Controlar a rinite também é importante; a escolha do tratamento deve considerar gravidade, riscos e benefícios.
Alergia e Gravidez > Bombinha na gravidez	medicação inalada, segurança gestacional	LEVE	Existem medicamentos inalados com bom perfil de segurança na gestação; manter acompanhamento médico e não suspender por medo sem orientação.
Alergia e Gravidez > Congestão nasal da gestação	nariz entupido na gravidez, edema e congestão nasal por alterações hormonais	LEVE	Nem toda congestão na gestação significa alergia; observar e discutir com o médico para diferenciar rinite gestacional de alergia.
Alergia e Gravidez > Planejamento reprodutivo	asma desde a infância, desejo de engravidar	LEVE	Asma controlada com tratamento adequado não impede gravidez; orientar seguimento antes e durante a gestação.
Alergia Dermatológica > Visão geral	pele, tendência hereditária, dermatite atópica, dermatite de contato, urticária, angioedema, estrófulo	LEVE	Reconhecer que a pele é frequentemente acometida nas alergias; orientar avaliação especializada quando lesões forem recorrentes, extensas ou de difícil controle.

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Alergia Dermatológica > Dermatite atópica > Lactentes	eczema, coceira intensa, lesões na face/bochechas, pescoço, couro cabeludo, dorso, braços e pernas	LEVE	Procurar acompanhamento para controle da inflamação e da coceira; monitorar extensão e recorrência das lesões.
Alergia Dermatológica > Dermatite atópica > Crianças maiores/adolescentes/adultos	lesões nas dobras dos cotovelos e joelhos, pescoço, eczema recorrente	LEVE	Manter seguimento clínico, hidratação e controle de fatores ambientais irritantes/alérgenos.
Alergia Dermatológica > Dermatite atópica > Casos disseminados	lesões intensas e disseminadas	MODERADA	Quando houver acometimento extenso ou importante impacto na qualidade de vida, encaminhar ao especialista para plano terapêutico estruturado.
Alergia Dermatológica > Tríade atópica	dermatite atópica, asma, rinite alérgica, predisposição genética, IgE elevada	LEVE	Explicar a relação entre as doenças atópicas e reforçar controle ambiental e acompanhamento longitudinal.
Alergia Dermatológica > Dermatite de contato	lesão limitada à área de contato, esmalte, perfumes, bijuterias, tintura de cabelo	LEVE	A base do tratamento é descobrir a causa e afastá-la; orientar teste de contato quando houver suspeita de substância específica.
Alergia Dermatológica > Dermatite por irritante primário	detergentes, água sanitária, ação direta sobre a pele	LEVE	Evitar contato com o agente irritante e proteger a pele; diferenciar de mecanismo alérgico.
Alergia Dermatológica > Dermatite alérgica de contato por esmalte/perfume	rosto inchado, coceira nos locais de contato, pálpebras acometidas	MODERADA	Suspender o produto suspeito e realizar teste de contato para confirmação e orientação específica.
Alergia Dermatológica > Bijuterias/piercing	alergia a bijuterias, níquel, aço cirúrgico	LEVE	Há chance baixa, mas existente, de complicação com aço cirúrgico; orientar cautela e evitar

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			materiais com níquel quando houver histórico.
Alergia Dermatológica > Tintura de cabelo	alergia a tinta/tonalizante, parafenilenodiamina, cosméticos escuros, henna	MODERADA	Suspender o uso do produto suspeito e realizar teste de contato para definir quais substâncias devem ser evitadas.
Alergia Dermatológica > Urticária > Lesões típicas	placas avermelhadas, coceira intensa, localização variável, duração fugaz	LEVE	Usar anti-histamínico para alívio dos sintomas conforme prescrição e investigar a causa com base na história clínica e exames quando necessário.
Alergia Dermatológica > Angioedema	inchaço em camadas profundas, lábios, pálpebras, mãos, pés, área genital, face	MODERADA	Procurar avaliação médica, especialmente se recorrente; observar progressão e sinais respiratórios.
Alergia Dermatológica > Angioedema hereditário	crises recorrentes, história familiar, resistência a anti-histamínicos, inchaço sem coceira, sem dor, sem vermelhidão, acometimento de intestinos, pulmão e laringe	GRAVE/CRÍTICA	Suspeitar de angioedema hereditário e encaminhar ao especialista; anti-histamínicos e corticosteroides não resolvem esse tipo. Red flags: edema em boca, língua, laringe e sintomas respiratórios.
Alergia Dermatológica > Angioedema hereditário > Gatilhos	traumas, procedimentos cirúrgicos, estresse, inibidores da ECA, anticoncepcional oral	MODERADA	Evitar gatilhos conhecidos quando possível e informar todos os profissionais de saúde sobre a suspeita/diagnóstico.
Alergia Dermatológica > Dermografismo	coceira após pressão/atrito na pele	LEVE	Tratar com anti-histamínicos, hidratação cutânea e evitar atrito/pressão; geralmente requer uso prolongado.
Alergia Dermatológica	lesões por dias, coceira	LEVE	Observar resposta ao

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
> Urticária aguda			anti-histamínico e investigar possíveis gatilhos recentes como alimentos, medicamentos ou infecções.
Alergia Dermatológica > Urticária crônica	lesões por mais de 6 semanas, persistência apesar do tratamento	MODERADA	Manter tratamento e investigação; explicar que o controle pode ser prolongado e exige persistência e relação de confiança com o médico.
Alergia Dermatológica > Urticária ao frio	coceira, vermelhidão, placas após vento frio, água fria, objetos gelados	MODERADA	Enquanto aguarda consulta, evitar exposição ao frio, mergulho em água gelada, viagens para locais frios e contato direto com gelo.
Alergia Dermatológica > Urticária solar	empolamento ao sol, piora no verão	MODERADA	Evitar exposição intensa; exposição progressiva e curta antes do verão pode ajudar. Anti-histamínicos costumam controlar bem.
Alergia Dermatológica > Urticária por agentes físicos	roupas apertadas, frio, calor, luz solar, suor	MODERADA	Identificar e evitar fatores físicos desencadeantes; manter seguimento se sintomas forem diários ou incapacitantes.
Alergia Dermatológica > Urticária incapacitante	placas diárias, coceira intensa, deformidade do rosto/corpo, incapacidade para trabalhar	MODERADA	Manter tratamento e investigação mesmo quando a causa não é encontrada; reforçar acompanhamento especializado para melhorar qualidade de vida.
Alergia Dermatológica > Estrófulo	alergia a picadas de pernilongos, borrachudos, mosquitos-pólvora, pulgas	LEVE	Orientar prevenção de picadas e controle ambiental de insetos; procurar avaliação se lesões forem

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			recorrentes ou intensas.
Alergia Alimentar > Conceito operacional	reação adversa a alimento, nem sempre alérgica, desafio diagnóstico e terapêutico	LEVE	Diferenciar alergia verdadeira de intolerância ou reação tóxica antes de impor restrições alimentares.
Alergia Alimentar > Alergia verdadeira	resposta imunológica exagerada, independente da quantidade ingerida	MODERADA	Quando o diagnóstico for comprovado, excluir totalmente o alimento e seus derivados.
Alergia Alimentar > Manifestações principais	urticária, angioedema, dermatite atópica, anafilaxia	MODERADA	Procurar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação de exclusão alimentar segura.
Alergia Alimentar > Reações não alérgicas	toxinas bacterianas, má conservação, diarreia, intolerância individual, intolerância à lactose	LEVE	Não rotular automaticamente como alergia; investigar mecanismo antes de restringir dieta.
Alergia Alimentar > Leite de vaca > Rotulagem	caseína, caseinato de cálcio/magnésio/sódio/potássio, soro de leite, soro animal, soro, lactalbumina, lactose, sabor artificial de manteiga, creme, creme azedo, proteína animal, gordura animal, flavorizante natural sabor caramelo, corante caramelo	LEVE	Ler rótulos com atenção e, diante de termos duvidosos, contatar o fabricante para confirmar presença de proteína do leite antes de incluir o produto na dieta.
Alergia Alimentar > Leite de vaca > Evitar restrição excessiva	bebê em dieta de substituição por soja	LEVE	Evitar exclusões desnecessárias; confirmar cuidadosamente a presença de leite nos industrializados para não restringir além do necessário.
Alergia Alimentar > Leite e catarro	asma, tosse, catarro, crença de que leite aumenta secreção	LEVE	Não retirar leite da dieta sem indicação; não há evidência de

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			aumento de catarro em quem não é alérgico ao leite.
Alergia Alimentar > Alergia ao leite de vaca > manifestações	dermatite atópica, urticária, diarreia, vômitos, anafilaxia	MODERADA	Suspeitar quando houver esses sintomas relacionados à ingestão; procurar confirmação diagnóstica antes de excluir o alimento.
Alergia Alimentar > Asma isolada e leite	asma como manifestação isolada de alergia ao leite é rara	LEVE	Não atribuir asma isolada ao leite sem investigação adequada; priorizar avaliação de viroses e ácaros em crianças pequenas.
Alergia Alimentar > Intolerância à lactose	diarreia, prisão de ventre, dor abdominal, sintomas restritos ao trato digestório	LEVE	Diferenciar de alergia ao leite; intolerância envolve dificuldade de digerir lactose, não reação imunológica às proteínas do leite.
Alergia Alimentar > Pimenta	ardor, olhos inchados, descamação nas pálpebras, pescoço vermelho, pele soltando	MODERADA	Considerar reação não alérgica pela capsaicina; procurar avaliação se recorrente para diferenciar irritação de alergia.
Alergia Alimentar > Reação em festa	olhos inchados, manchas vermelhas pelo corpo após camarão, bacalhau, nozes, amendoim, doces, refrigerantes	MODERADA	Suspeitar principalmente de camarão, bacalhau, nozes ou amendoim; investigar com IgE específica ou testes cutâneos.
Alergia Alimentar > Camarão	principal causa de alergia alimentar em adultos no Brasil	MODERADA	Confirmar diagnóstico com exames apropriados e orientar exclusão rigorosa se confirmado.
Alergia Alimentar > Corantes/chocolate	crença popular de alergia a corantes e chocolate	LEVE	Informar que reações alérgicas a esses itens são raras; priorizar investigação dos alimentos com maior

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			potencial alergênico.
Alergia Alimentar > Camarão e contraste iodado	medo de reação por “iodo”	LEVE	Explicar que alergia a camarão não é fator de risco para reação a contraste iodado; não contraindicar exame por esse motivo isoladamente.
Alergia Alimentar > Contraste iodado > fatores de risco reais	reação prévia a contraste, doença cardiovascular, insuficiência renal, idade acima de 50 anos	MODERADA	Se houver esses fatores, comunicar a equipe antes do exame e planejar avaliação de risco.
Alergia Alimentar > Ovo e vacina febre amarela	alergia comprovada ao ovo, necessidade de vacina	MODERADA	Em pacientes com alergia comprovada ao ovo, testar a vacina contra febre amarela em ambiente hospitalar antes da administração.
Anafilaxia > Definição	reação alérgica grave, generalizada, emergência médica	GRAVE/CRÍTICA	Procurar atendimento de emergência imediatamente; após estabilização, realizar acompanhamento posterior com alergista.
Anafilaxia > Sinais cutâneos e respiratórios	placas vermelhas na pele, falta de ar, chiados	GRAVE/CRÍTICA	Red flags claros de anafilaxia; administrar adrenalina precocemente quando indicada e acionar emergência.
Anafilaxia > Sinais digestivos e cardiovasculares	cólicas abdominais, aceleração cardíaca, alteração da pressão arterial	GRAVE/CRÍTICA	Considerar anafilaxia mesmo com sintomas em múltiplos sistemas; atendimento imediato é obrigatório.
Anafilaxia > Evolução	choque, óbito	GRAVE/CRÍTICA	Situação crítica com risco de vida; não observar em casa.
Anafilaxia > Causas comuns	alimentos, medicamentos, látex, venenos de insetos	MODERADA	Após evento agudo, investigar a causa para prevenção de recorrência.
Anafilaxia > Prevenção	investigação correta de	LEVE	Confirmar o agente

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
	reações anteriores, cuidados preventivos		causal e orientar medidas de evicção e plano de emergência.
Anafilaxia > Adrenalina	uso precoce salva vidas	GRAVE/CRÍTICA	Em suspeita de anafilaxia, a adrenalina deve ser aplicada precocemente conforme orientação médica e o paciente deve seguir para atendimento emergencial.
Anafilaxia > Camarão com edema de glote	edema de glote, necessidade de adrenalina e corticoide	GRAVE/CRÍTICA	Edema de glote é manifestação grave com risco de vida; procurar emergência imediatamente. Após o evento, confirmar diagnóstico com IgE específica.
Anafilaxia > Corticoide após anafilaxia	prevenção de recorrência horas após quadro inicial	MODERADA	Após estabilização, corticosteroides podem ser usados para prevenir recorrência tardia dos sintomas, conforme conduta médica.
Anafilaxia > Frutos do mar relacionados	camarão, lagosta, lagostim, caranguejo, siri	MODERADA	Se houver alergia a camarão, avaliar sensibilização aos demais frutos do mar, pois o risco de reação cruzada é alto.
Anafilaxia > Picada de marimbondo	inchaço no rosto, falta de ar, dor de barriga, pressão baixa	GRAVE/CRÍTICA	Quadro compatível com choque anafilático; atendimento emergencial imediato. Após o evento, confirmar com IgE específica e planejar prevenção.
Anafilaxia > Imunoterapia para insetos	marimbondo, vacinas hipossensibilizantes	MODERADA	Indicar imunoterapia como prevenção de longo prazo em casos confirmados de

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			anafilaxia por picada de insetos.
Anafilaxia > Autoaplicador de adrenalina	nova reação à picada de inseto, histórico de anafilaxia	GRAVE/CRÍTICA	Manter autoaplicador sempre disponível para uso em emergência; paciente e cuidadores devem ser treinados para reconhecer sintomas e aplicar corretamente.
Anafilaxia > Reação durante cirurgia	alergia grave intraoperatória, anestesia, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, opioides, antibióticos, coloides, látex	GRAVE/CRÍTICA	Após estabilização, a investigação deve ser meticulosa com revisão de prontuário, cronologia da reação e testes específicos conforme suspeita.
Anafilaxia > Seguimento pós-evento	acompanhamento posterior com alergista	MODERADA	Todo episódio de anafilaxia exige investigação especializada posterior para definir causa, prevenção e necessidade de adrenalina autoinjetável.
Reações Adversas a Medicamentos > Conceito geral	efeito indesejável relacionado ao uso do medicamento	LEVE	Diferenciar reação adversa geral de alergia verdadeira antes de rotular o paciente como “alérgico”.
Reações Adversas a Medicamentos > Fatores predisponentes	predisposição genética, atopia, HIV, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática	MODERADA	Considerar maior risco nesses grupos e registrar cuidadosamente histórico de reações.
Reações Adversas a Medicamentos > Fármacos mais envolvidos	antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, anti-hipertensivos, anestésicos, contrastes iodados, hormônios, soros	MODERADA	Em caso de reação, suspender o medicamento suspeito até avaliação médica, especialmente se houver sintomas cutâneos ou sistêmicos.
Reações Adversas a	toxicidade por dose	LEVE	Avaliar mecanismo

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Medicamentos > Reações não alérgicas	excessiva, gastrite por anti-inflamatório, interação medicamentosa com sonolência		antes de contraindicar definitivamente o medicamento; pode não ser alergia.
Reações Adversas a Medicamentos > Anestésico local no dentista	mal-estar súbito, pés gelados, tremedeira, crise de choro, melhora com soro	MODERADA	O relato não sugere alergia típica; investigar reações vagais, tóxicas ou superdosagem. Se necessário, confirmar com teste de provocação em ambiente hospitalar.
Reações Adversas a Medicamentos > Teste sanguíneo para medicamentos	exame de sangue para alergia medicamentosa	LEVE	Explicar que a investigação por sangue é limitada e não cobre “todos os medicamentos”; a avaliação deve integrar história clínica, exame físico e testes específicos.
Reações Adversas a Medicamentos > Exames disponíveis	penicilina, amoxicilina, insulina, suxametônio	LEVE	Solicitar exames laboratoriais apenas quando houver indicação e disponibilidade para esses poucos medicamentos.
Reações Adversas a Medicamentos > Dipirona/aspirina/anti-inflamatórios	olhos inchados, intolerância a múltiplos fármacos de ação semelhante	MODERADA	Evitar os medicamentos relacionados e manter consigo uma lista dos nomes a serem evitados.
Reações Adversas a Medicamentos > Alergia não ocorre na primeira exposição	uso repetido ao longo do tempo, sensibilização	LEVE	Orientar que reações podem surgir após usos prévios sem problema; registrar o histórico com precisão.
Reações Adversas a Medicamentos > Dessensibilização	necessidade imperiosa do fármaco, ausência de substituto	MODERADA	Reservar dessensibilização para situações específicas e sob supervisão especializada; explicar

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			que o efeito não persiste após suspensão e pode ser necessário repetir.
Reações Adversas a Medicamentos > “Alergia a todos os antibióticos”	relato amplo e inespecífico	MODERADA	Considerar esse cenário extremamente raro; o mais importante é definir exatamente a quais antibióticos houve reação.
Ambiente > Ácaros > Características	seres microscópicos, fezes alergênicas, umidade >50%, clima quente e úmido	LEVE	Orientar controle ambiental contínuo, especialmente no dormitório, para reduzir exposição.
Ambiente > Dormitório do alérgico	colchões, travesseiros, roupas de cama, carpetes, estofados	LEVE	Dar atenção especial ao quarto: encapar colchões e travesseiros, trocar roupa de cama semanalmente e reduzir reservatórios de poeira.
Ambiente > Umidificador	uso no quarto, névoa de água, aumento da umidade	MODERADA	Não indicar para quartos de pessoas alérgicas, salvo orientação específica do especialista, pois favorece ácaros e fungos.
Ambiente > Fungos e umidade	infiltração, umidade, mofo	MODERADA	Consertar focos de infiltração e reduzir umidade para evitar agravamento de alergia respiratória.
Ambiente > Animal doméstico	cachorro, epitélio de cão, asma	MODERADA	Confirmar sensibilização se necessário; se o animal permanecer em casa, banhá-lo semanalmente e restringir circulação nos dormitórios, camas e estofados.
Ambiente > Imunoterapia para alérgeno animal	alergia a cão	MODERADA	Considerar imunoterapia como complemento do tratamento quando

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			indicada pelo especialista.
Ambiente > Clima	cidade fria, poluição, ambiente seco/úmido	LEVE	Não há clima ideal universal; avaliar poluição, umidade e condições da residência. Ambientes menos poluídos e mais secos podem favorecer alguns pacientes.
Ambiente > Exercício físico na asma	esporte, atividade física, autoestima, qualidade de vida	LEVE	Asma bem controlada não incapacita; a criança deve praticar o esporte de sua preferência.
Ambiente > Natação e rinite	piscina aquecida, água salinizada, cloro, irritação nasal	LEVE	Natação pode ser excelente, mas a indicação depende da gravidade da rinite; alguns pacientes pioram com piscina clorada.
Ambiente > Casa saudável > ventilação	janelas abertas durante o dia	LEVE	Melhorar ventilação da casa; vento não faz mal segundo o guia.
Ambiente > Casa saudável > limpeza	limpeza diária com pano úmido, evitar odor forte	LEVE	Fazer limpeza diária com pano úmido e evitar produtos de limpeza com cheiro forte.
Ambiente > Casa saudável > ar-condicionado e ventiladores	filtros, poeira acumulada	LEVE	Limpar ventiladores e filtros do ar-condicionado regularmente.
Ambiente > Casa saudável > animais no quarto	exposição noturna a alérgenos	LEVE	Evitar animais no quarto de dormir.
Ambiente > Casa saudável > mobiliário	móveis simples, fácil limpeza	LEVE	Preferir mobiliário simples e de fácil limpeza.
Ambiente > Casa saudável > roupas guardadas	poeira em roupas armazenadas	LEVE	Lavar roupas guardadas antes do uso.
Ambiente > Casa	fumaça de cigarro,	MODERADA	Controlar fatores

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
saudável > irritantes	odores, umidade		irritantes e evitar exposição, especialmente em pacientes com asma e rinite.
Métodos Diagnósticos > Base diagnóstica	anamnese, histórico clínico, exame físico	LEVE	O diagnóstico das alergias é principalmente clínico; exames complementam ou confirmam quando necessário.
Métodos Diagnósticos > Testes cutâneos imediatos	puntura, leitura imediata	LEVE	Utilizar quando indicado para investigar sensibilização alérgica, sempre interpretando junto com a história clínica.
Métodos Diagnósticos > Teste de contato	dermatite de contato, substâncias suspeitas	LEVE	Indicar quando houver suspeita de alergia por contato, como esmaltes, perfumes e tinturas.
Métodos Diagnósticos > Exames laboratoriais	IgE total, IgE específica	LEVE	Solicitar para complementar investigação, não como substituto isolado da avaliação clínica.
Métodos Diagnósticos > Imagem	radiografias, tomografias	LEVE	Utilizar quando necessário para investigar complicações ou diagnósticos diferenciais, como sinusite.
Métodos Diagnósticos > Testes de provocação	medicamentos, anestésicos, substâncias suspeitas	MODERADA	Realizar apenas em ambiente apropriado e com supervisão especializada, devido ao risco de reação.
Métodos Diagnósticos > Dietas de eliminação	suspeita de alergia alimentar	MODERADA	Usar de forma orientada para evitar restrições excessivas e garantir interpretação correta.

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Métodos Diagnósticos > Pele versus sangue	teste cutâneo, exame de sangue, idade, gravidade, medicações, lesões extensas de pele, disponibilidade regional	LEVE	Ambos têm boa acurácia quando bem indicados; a escolha depende do contexto clínico.
Métodos Diagnósticos > Sensibilização a ácaros	Dermatophagoides farinae, pteronyssinus, Blomia tropicalis	LEVE	Interpretar como sensibilização a ácaros da poeira domiciliar; orientar controle ambiental e considerar imunoterapia específica.
Métodos Diagnósticos > IgE total elevada	151 UI/mL em criança, predisposição alérgica	LEVE	Interpretar em conjunto com história pessoal/familiar e exame físico; isoladamente não define doença.
Métodos Diagnósticos > Teste em crianças pequenas	1 ano e 8 meses, sem idade mínima fixa	LEVE	Não existe idade limite para testes cutâneos; o importante é haver indicação correta e interpretação por especialista.
Métodos Diagnósticos > ImmunoCAP	dosagem quantitativa de IgE específica, método enzimático não radioativo	LEVE	Utilizar para detectar presença e grau de sensibilização a alérgenos; é mais sensível e específico que métodos antigos.
Tratamento > Asma > Bombinha e coração	uso prolongado, atleta, broncodilatadores inalados	LEVE	Explicar que os inaladores são seguros quando bem indicados e não fazem mal ao coração segundo o guia.
Tratamento > Asma > Broncodilatador inalatório	alívio dos sintomas agudos, uso antes do exercício	LEVE	Pode ser usado preventivamente antes do exercício programado em asmáticos, conforme orientação médica.
Tratamento > Asma > Nebulização em	várias vezes ao dia, medo de “secar o	MODERADA	Nebulização não “seca o pulmão”; porém, se

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
criança	pulmão”		broncodilatador for necessário várias vezes ao dia, isso indica descontrole e necessidade imediata de avaliação médica.
Tratamento > Asma > Corticoide inalado contínuo	uso 1-2 vezes ao dia, controle e prevenção	LEVE	Manter uso contínuo conforme prescrição; é seguro em lactentes e pré-escolares quando segue plano de ação médico.
Tratamento > Asma > Interrupção do preventivo	sem crises fortes, uso há anos	LEVE	A suspensão depende do grau de controle da asma, sintomas noturnos e impacto nas atividades; deve ser decidida em consulta.
Tratamento > Asma > Prova de função pulmonar	avaliação do funcionamento dos pulmões	LEVE	Sempre que possível, usar para acompanhar controle da asma e apoiar decisões terapêuticas.
Tratamento > Imunoterapia	vacina antialérgica, 3 a 5 anos	LEVE	Em geral é usada por 3 a 5 anos e deve ser feita em conjunto com o tratamento medicamentoso.
Tratamento > Corticoide sistêmico > mecanismo	cortisona, corticosteroide, cortisol, ação anti-inflamatória	LEVE	Explicar ao paciente que é um medicamento potente e útil, mas que exige uso correto e acompanhamento.
Tratamento > Corticoide sistêmico > risco de Cushing	uso intramuscular mensal por 6 meses, síndrome de Cushing	MODERADA	Evitar via intramuscular sempre que possível; o uso prolongado deve ser acompanhado de perto por médico experiente.
Tratamento > Corticoide sistêmico > segurança em curto prazo	uso por menos de 10 dias	LEVE	O uso por períodos inferiores a 10 dias é considerado bastante seguro, sem efeitos colaterais importantes.
Tratamento >	uso a cada 3 meses,	MODERADA	Corticoide oral

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
Prednisolona frequente	crises frequentes de bronquite asmática		frequente pode causar efeitos adversos; usar apenas nas crises sob prescrição médica e considerar corticoide inalado contínuo para reduzir recorrência.
Tratamento > Rinite > Corticoide intranasal	maior eficácia, segurança, diferenças entre moléculas	LEVE	São os medicamentos mais eficazes para controle da rinite alérgica e geralmente bastante seguros; a escolha depende da idade e aceitação individual.
Tratamento > Vasoconstritor nasal	gotas nasais, uso por 4 meses, ressecamento, entupimento	MODERADA	Interromper o uso continuado com orientação médica, pois pode causar vício e rinite medicamentosa.
Tratamento > Vasoconstritor nasal > efeitos adversos	alteração do sono, tontura, tremor, dor de cabeça, taquicardia, hipertensão arterial	MODERADA	Red flags para uso inadequado; procurar avaliação médica para substituir por tratamento apropriado.
Tratamento > Anti-histamínicos	antialérgicos, rinite, alergia ocular, urticária, alívio rápido	LEVE	Usar para alívio dos sintomas e, quando necessário, por tempo prolongado sob orientação médica.
Tratamento > Anti-histamínicos antigos	sonolência, prejuízo da atenção, dirigir, operar máquinas	LEVE	Orientar cautela em atividades que exigem atenção; considerar compostos mais modernos quando possível.
Tratamento > Anti-histamínicos modernos	melhor tolerabilidade e segurança	LEVE	Preferir quando houver necessidade de uso prolongado ou preocupação com sedação.
Tratamento > Plano terapêutico	passo a passo para crises, supervisão médica	LEVE	Todo paciente com asma/rinite recorrente deve ter um plano claro de manejo das crises e

Categoria	Sintomas/Palavras-chave	Gravidade	Conduta Recomendada (Texto Amigável)
			do tratamento preventivo.
Tratamento > Seguimento longitudinal	exame clínico regular, monitoramento do uso correto, avaliação do controle	LEVE	Manter consultas regulares para revisar técnica, adesão, gatilhos e necessidade de ajuste terapêutico.
Red Flags Transversais > Emergência	falta de ar importante, chiado intenso, edema de glote, pressão baixa, choque, acometimento de múltiplos sistemas	GRAVE/CRÍTICA	Procurar atendimento de emergência imediatamente; não observar em casa.
Red Flags Transversais > Procurar especialista	sintomas recorrentes, necessidade repetida de antibióticos, urticária crônica, angioedema recorrente, suspeita de alergia alimentar, reação medicamentosa, anafilaxia prévia	MODERADA	Encaminhar ao alergista para investigação etiológica, prevenção e plano de seguimento.
Prevenção Transversal > Controle ambiental	ácaros, fungos, fumaça, odores fortes, umidade, animais no quarto	LEVE	Implementar medidas ambientais de forma contínua, especialmente no dormitório do paciente alérgico.
Prevenção Transversal > Educação do paciente	reconhecer sintomas, diferenciar alergia de outras causas, evitar automedicação	LEVE	Orientar de forma clara e objetiva, reforçando que diagnóstico e tratamento corretos reduzem crises, complicações e ansiedade.
Seguimento Pós-Evento Agudo > Anafilaxia e reações graves	evento agudo resolvido, necessidade de investigação posterior	MODERADA	Após estabilização, agendar avaliação com alergista para confirmar causa, orientar prevenção e definir necessidade de autoaplicador de adrenalina ou imunoterapia.

O tom de voz dos médicos da ASBAI é calmo e acolhedor, procurando reduzir a ansiedade do paciente com explicações simples e diretas. Eles transmitem clareza ao diferenciar conceitos

confundidos com frequência, como alergia versus intolerância, rinite versus infecção e reação adversa versus alergia medicamentosa. Também passam segurança ao orientar condutas práticas, reforçar prevenção e indicar com objetividade quando observar, quando procurar especialista e quando buscar emergência.